TEMA 48 · Conceptos de urgencia y emergencia. Sistemas de respuesta a la urgencia y emergencia. Clasificación de pacientes en urgencias

Resumen OPE Enfermería SMS · Urgencia frente a emergencia, RD 1030/2006 y Ley 41/2002, Gerencia 061 de Murcia (CCU, UME, SUAP, PAC, PEA), RAC, triaje avanzado, indicadores SEMES, ESI, Manchester, SET-MAT, fiabilidad, triaje en catástrofes (colores, START, SHORT, JumpSTART), sectorización y SAER

1. Conceptos y marco legal

	Urgencia	Emergencia
Definición	**OMS**: problema de gravedad variable que genera la **conciencia de una necesidad inminente de atención** en quien lo sufre o su familia (componente **subjetivo**)	Situación que pone en **peligro inminente la vida** o la **viabilidad de un órgano**
Tiempo	Minutos a horas; sin riesgo vital inmediato (puede evolucionar a emergencia)	**Minutos o segundos**; el tiempo determina el pronóstico
Ejemplos	Cólico renal, fractura cerrada, fiebre	**PCR, infarto, ictus, anafilaxia, hemorragia exanguinante**

- **Real Decreto 1030/2006** (cartera de servicios comunes del SNS, **anexo IV**): atención urgente **24 h**, dentro y fuera de los centros (domicilio, vía pública): **atención telefónica y regulación** por los centros coordinadores, **evaluación inicial**, **clasificación (triaje)**, procedimientos diagnósticos y terapéuticos y **transporte sanitario**.
- **Ley 41/2002**: se puede intervenir **sin consentimiento** cuando hay **riesgo inmediato grave** para la integridad física o psíquica **y no es posible conseguir la autorización** (consultando a los familiares cuando se pueda).

2. Red de urgencias y emergencias de la Región de Murcia (Gerencia 061)

- **CCU** (Centro Coordinador de Urgencias, Murcia): recibe **todas las llamadas**, hace el **triaje telefónico** y moviliza el **recurso más adecuado**; también cubre dispositivos de riesgo previsible (fiestas, eventos).
- **UME** (Unidad Médica de Emergencias): **recurso móvil de soporte vital avanzado** para emergencias con riesgo vital; **médico, enfermero, técnico en emergencias sanitarias y conductor**, en turnos de 24 h. El manual cita **17 bases** (Murcia y Cartagena tienen **dos** cada una).
- **SUAP** (Servicio de Urgencias de Atención Primaria): **dispositivo fijo** que atiende cuando cierran los centros de salud (tardes, noches, fines de semana y festivos); dotado de carro de parada y desfibrilador para estabilizar hasta que llegue la UME (el manual cita 28).
- **PAC** (Puntos de Atención Continuada): cabeceras de comarcas periféricas. **PEA** (Puntos de Especial Aislamiento): pedanías y zonas de montaña de muy difícil acceso.
- Objetivos de los **Acuerdos de Gestión** citados en el manual: emergencias **A1** atendidas en **< 15 min** (≥ 95%); urgencias **A2** en **< 30 min** (≥ 90%); código infarto con **fibrinólisis ≤ 30 min** y llegada a hemodinámica **< 60 min**; ≥ 40% de las asistencias del SUAP resueltas por enfermería; revisión **diaria del carro de parada**; notificación de incidentes en **SiNASP**.

3. Recepción, Acogida y Clasificación (RAC)

- **Recepción** (datos administrativos) → **Acogida** (contacto empático, «**triaje visual de puerta**»: detectar al paciente que no puede esperar) → **Clasificación** (valoración estructurada con anamnesis dirigida y constantes).
- El triaje **no emite diagnósticos**: **gestiona el riesgo clínico** según la **urgencia fisiológica**, no según las camas o el personal disponibles. La **enfermera** es la profesional idónea para hacerlo con un sistema estructurado.
- **Sospecha de violencia de género o maltrato** (lesiones que no encajan, retraso en consultar, acompañante controlador que responde por el paciente): **separar al acompañante con un pretexto clínico rutinario** (ECG, constantes, normativa del box) y **entrevistar a solas**; **nunca confrontar** al presunto agresor; después, protocolos y **parte de lesiones**.

- **Box de triaje (SEMES)**: a la entrada, con visión de admisión y sala de espera; **mínimo 6 m²** (óptimo 9). **Paciente agitado**: la enfermera **siempre más cerca de la puerta**, distancia de 1-2 m, brazos visibles, tono sereno, botón de alarma; si hay riesgo inminente, **salir y activar el protocolo** de paciente violento.
- **Triaje avanzado**: intervenciones protocolizadas **antes de la valoración médica**: **analgesia oral** (paracetamol, dexketoprofeno), **antitérmicos** pediátricos por peso, **petición de radiografías** en traumatismos aislados, **inmovilización y frío**, **tira de orina**, analítica. **No** incluye pautar morfina IV ni diagnosticar.

Indicador de calidad (SEMES)	Estándar
Tiempo llegada-triaje	**< 10 min** (≥ 85% de los casos)
Fugas antes del triaje	**< 4%**
Fugas de pacientes ya triados	**< 2%**
Reevaluación si se supera el tiempo o empeora	**Obligatoria**
Relación nivel-ingreso	A más gravedad, más ingresos

4. Sistemas de triaje estructurado

- Todo sistema válido tiene **5 niveles**, cada uno con un tiempo máximo de atención. **ATS** australiana (1993; 0-10-30-60-120 min) y **CTAS** canadiense (0-15-30-60-120; destaca la **agudeza y el riesgo de deterioro**).
- **ESI** (*Emergency Severity Index*, EE. UU.): **sin tiempos fijos**; algoritmo de 4 puntos:
- **A** → ¿necesita una **intervención salvavidas inmediata**? → **nivel 1**. Cuentan: intubación, ventilación, desfibrilación, marcapasos, descompresión con aguja, fluidos masivos, **adrenalina, atropina, adenosina, naloxona**. **No** cuentan: TAC, vía periférica, analítica.
- **B** → ¿**alto riesgo**, confusión o letargo nuevos, **dolor o distrés intenso**? → **nivel 2** (dolor torácico isquémico, sepsis, ideación suicida, neutropenia febril…).
- **C** → **número de recursos previstos**: **≥ 2** → **nivel 3**; **1** → **nivel 4**; **ninguno** → **nivel 5**. Son recursos: **laboratorio** (sangre y orina juntas = **1**), radiografía, TAC, eco, fluidos o medicación **IV/IM**, interconsulta, **sutura compleja**, sondaje vesical. **No** lo son: historia y exploración, **medicación oral o tópica**, férula o vendaje simple, muletas, **antitetánica**, cura simple, retirar puntos, receta.
- **D** → **constantes de peligro** en un nivel 3 → considerar **subir a nivel 2**.
- **Manchester (MTS)** (Reino Unido, 1996): **52 diagramas de flujo** por **motivo de consulta** (49 pediátricos); preguntas Sí/No (**discriminadores generales**: vía aérea, conciencia, hemorragia, shock, temperatura, dolor; y **específicos** de cada diagrama, p. ej., **exantema que no blanquea** en el niño febril). Se recorren **de arriba abajo** y se para en el primer «sí». Tiene **infratriaje** relevante en **mayores de 65 años** (presentaciones atípicas).
- **SET-MAT** (Sistema Español de Triaje, a partir del **Modelo Andorrano**): recomendado por **SEMES**; **> 600 motivos** organizados en categorías sintomáticas, cruzados con discriminantes (conciencia, constantes, dolor, dificultad respiratoria…); **requiere software**: **e-PAT** (programa de ayuda al triaje).

Nivel	**Manchester** (color · tiempo)	**SET** (según el manual)
1	**Rojo** · inmediato (0 min)	Resucitación · inmediato
2	**Naranja** · **10 min**	Emergencia · 15 min
3	**Amarillo** · **60 min**	Urgente · **30 min**
4	**Verde** · **120 min**	Menos urgente · 60 min
5	**Azul** · **240 min**	No urgente · 120 min

- Otras fuentes del SET-MAT dan **inmediato, 7, 30, 45 y 60 min**; el valor común es el **nivel III a 30 min**.
- **Fiabilidad** (concordancia interobservador: dos enfermeras asignan el mismo nivel) → **índice kappa** (> 0,8 excelente; 0,6-0,8 buena). **Validez**: clasifica bien la gravedad real (ingresos, recursos, mortalidad). El mayor riesgo para la seguridad es el **infratriaje**.

5. Triaje en incidentes de múltiples víctimas (IMV)

- Cambia la ética: de atender primero al más grave a **el mayor beneficio para el mayor número** con los recursos disponibles; **no se hace RCP** en el primer triaje.

Color	Prioridad	Víctima
Rojo	1 · inmediata	Crítico **pero recuperable** (shock tratable, neumotórax a tensión, vía aérea resoluble)
Amarillo	2 · demorable	Grave pero **estable** unas horas (fractura abierta estable, quemadura < 20%)
Verde	3 · leve	**Camina** por sí mismo
Negro	4 / 0	**Fallecido** o lesiones incompatibles con la vida con los recursos disponibles

- Los **verdes** se agrupan en un punto de reunión seguro (evita el pánico y que bloqueen la evacuación). **Primeros auxilios psicológicos**: apoyo no intrusivo y necesidades básicas, **sin forzar el relato** del trauma. Equipos: *defusing* en las primeras horas y *debriefing* a las 24-72 h.
- **START** (adultos, **< 60 s** por víctima; regla **«30 - 2 - puede hacerlo»**): 1. **¿Camina?** → **verde**. 2. **¿Respira?** No → abrir la vía aérea: si respira → **rojo**; si no → **negro**. **FR > 30** (o < 10) → **rojo**. 3. **Perfusión**: **relleno capilar > 2 s** o **sin pulso radial** → **rojo**. 4. **¿Obedece órdenes sencillas?** No → **rojo**; sí → **amarillo**.
- Únicas maniobras: **abrir la vía aérea** y **controlar hemorragias** (y posición lateral de seguridad).
- **SHORT** (español, **< 30 s**, para intervinientes no sanitarios; sin contar frecuencias ni tomar pulsos): **S**ale caminando → verde; **H**abla sin dificultad y **O**bedece órdenes → amarillo; **R**espira (o respira tras abrir la vía aérea) → rojo; no respira → negro; **T**aponar hemorragias en **cualquier momento** (no cambia el color).
- **JumpSTART** (niños de **1 a 8 años**): si no respira tras abrir la vía aérea → **palpar el pulso**; **sin pulso** → **negro**; **con pulso** → **5 ventilaciones de rescate**: si respira → rojo; si no → negro. Rojo si **FR < 15 o > 45**.
- **Sectorización**: **zona caliente** (área de **rescate**; primer triaje) → **zona templada** (área de **socorro**: **Puesto Médico Avanzado**, segundo triaje y estabilización) → **zona fría** (área **base**: puesto de mando, prensa, **noria de evacuación** con las ambulancias).
- **Transferencia (SAER / SBAR)**: **S**ituación (qué ocurre ahora), **A**ntecedentes (alergias, enfermedades, fármacos), **E**valuación (constantes, estado, lo realizado) y **R**ecomendación (qué necesita).

TRAMPAS DE EXAMEN

! Urgencia = **percepción subjetiva** de necesidad (OMS); emergencia = **riesgo vital o de un órgano**.

! El triaje es obligatorio por el **RD 1030/2006**; sin consentimiento solo si **riesgo grave inmediato y no se puede obtener** (Ley 41/2002).

! UME = **móvil, SVA**; SUAP = **fijo**; PAC = comarca periférica; PEA = zona aislada.

! El triaje **no diagnostica**: **gestiona el riesgo clínico**.

! Violencia sospechada: **separar al acompañante con un pretexto**, nunca confrontar.

! Box **≥ 6 m²**; llegada-triaje **< 10 min**; fugas **< 4%** antes y **< 2%** después del triaje.

! Triaje avanzado: **analgesia oral, antitérmicos, radiografías, inmovilización**; no morfina IV.

! ESI: **sin tiempos**; niveles 3-4-5 según **recursos** (≥ 2 / 1 / 0); sangre + orina = **1 recurso**; medicación oral **no** es recurso.

! **Manchester: 52 diagramas; nivel 2 naranja 10 min; 4 verde (120), 5 azul (240); infratriaje en ancianos.**

! SET-MAT: **software e-PAT**; nivel III **30 min**.

! Fiabilidad entre observadores = **índice kappa**.

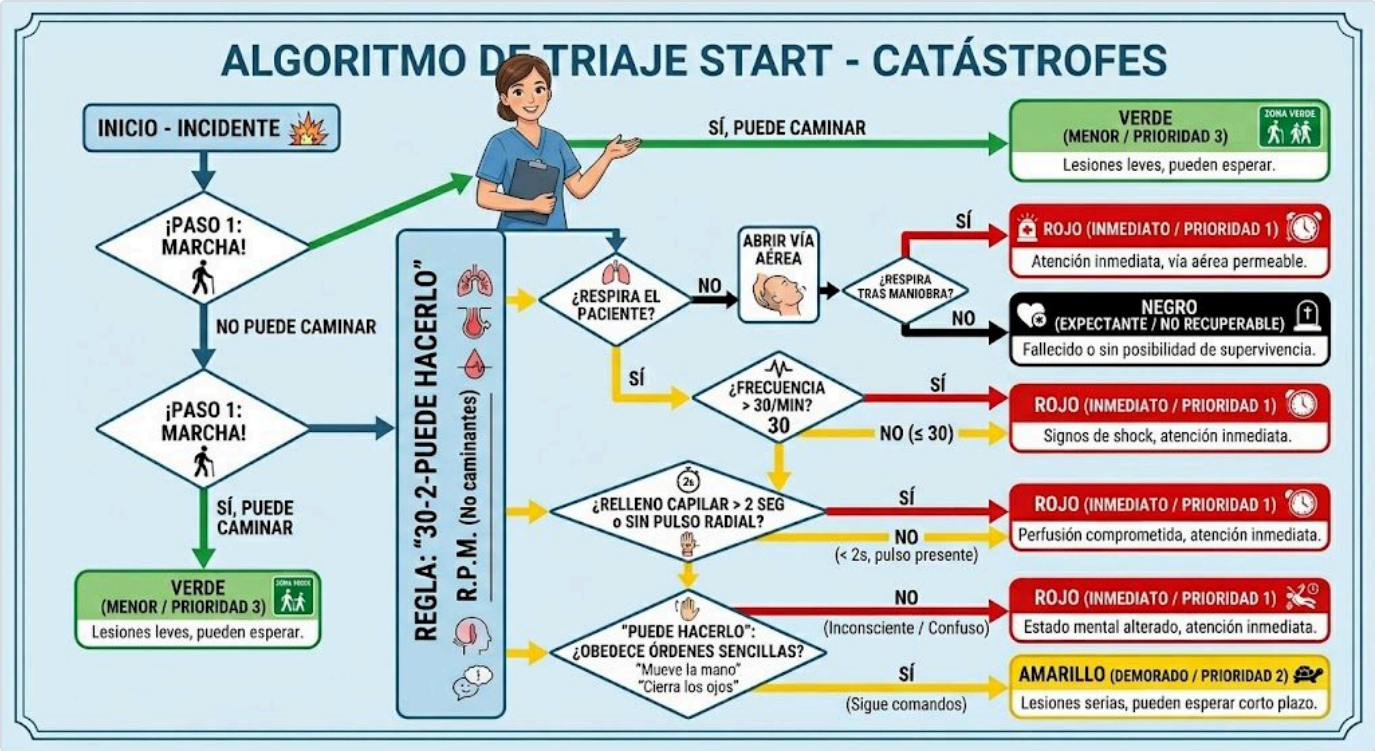
! **START: camina → verde; no respira tras abrir vía → negro; FR > 30, relleno > 2 s o no obedece → rojo; resto amarillo.**

! JumpSTART: niño con pulso que no respira → **5 ventilaciones** antes del negro.

! PMA en la **zona templada**; ambulancias en la **zona fría**.

! SAER: **S**ituación, **A**ntecedentes, **E**valuación, **R**ecomendación.

Imágenes clave del tema



Algoritmo de triaje START en catástrofes